

RELATÓRIO MÉDICO

Relato a pedido que **PEDRO ANDRADE MENEZES** encontra-se em acompanhamento médico regular, apresentando diagnóstico conforme CID-11: **6A05.2 (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – apresentação combinada)**, **6A01.21 (transtorno do desenvolvimento da linguagem)** e **6A03.3 (transtorno específico da aprendizagem com prejuízo PRINCIPALMENTE na expressão escrita)**, com evidência clínica de **atraso em consciência fonológica, prejuízo em coordenação motora fina e características compatíveis com disgrafia**.

O paciente apresenta sintomas desde a primeira infância, associados a fatores maturacionais e emocionais secundários, com impacto funcional significativo nos domínios **acadêmico, comportamental, emocional e social**. Observa-se prejuízo relevante em **funções executivas** (atenção sustentada, memória operacional, planejamento e organização), associado a dificuldades na **execução motora fina**, organização gráfica e produção escrita, interferindo diretamente na autonomia e desempenho escolar.

1. PERFIL NEUROFUNCIONAL

- Déficits em **freio inibitório** (impulsividade e dificuldade de autorregulação);
- Prejuízo em **flexibilidade cognitiva** e adaptação a mudanças;
- Comprometimento de **atenção sustentada e seletiva**;
- Dificuldades em **planejamento e organização de tarefas**;
- Alterações em **coordenação motora fina**, com impacto na escrita (disgrafia);
- Prejuízo em **consciência fonológica e decodificação**, interferindo no processo de alfabetização;
- Repercussões emocionais secundárias (frustração, insegurança e possível evitamento de tarefas escolares).

2. PLANO TERAPÊUTICO MULTIPROFISSIONAL (INDIVIDUALIZADO)

O tratamento deve ser mantido de forma contínua, estruturada e integrada entre equipe, família e escola:

• Psicologia (Terapia Cognitivo-Comportamental – 1h/semana) E PSICOPEDAGOGA (2H/SEMANA)

Foco em:

- Treinamento de funções executivas;
- Autorregulação emocional e comportamental;
- Redução da impulsividade;
- Treino de habilidades sociais;
- Desenvolvimento de estratégias compensatórias para organização e rotina.

• Fonoaudiologia (2h/semana)

Foco em:

- Consciência fonológica;
- Decodificação e fluência de leitura;
- Processamento fonológico;
- Estratégias para linguagem escrita.

• Terapia Ocupacional (2h/semana)

Foco prioritário em:

- **Coordenação motora fina**;
- Treino grafomotor (disgrafia);

- Integração visuomotora;
- Planejamento motor e execução de tarefas;
- Estratégias de adaptação funcional para escrita e atividades escolares.

3. RECOMENDAÇÕES ESCOLARES

Diante do perfil neurofuncional, são necessárias **adaptações pedagógicas estruturadas**, visando equidade no processo de aprendizagem:

Organização e ambiente:

- Posicionar o aluno **próximo ao professor**, reduzindo estímulos distratores;
- Ambiente com menor carga de estímulos visuais e auditivos durante atividades avaliativas;
- Supervisão indireta frequente para manutenção do engajamento.

Execução de tarefas:

- **Tempo adicional** para atividades e avaliações;
- Fracionamento de tarefas longas em etapas menores;
- Redução da quantidade sem prejuízo do conteúdo;
- Orientações claras, objetivas e passo a passo.

Aspectos grafomotores e disgrafia:

- Permitir uso de **letras maiores, espaçamento ampliado e pauta adaptada**;
- Reduzir exigência de cópia extensa;
- Priorizar qualidade sobre quantidade;
- Possibilidade de uso de recursos alternativos (digitador, apoio visual, respostas orais);
- Avaliar mais o conteúdo do que a estética da escrita.

Aprendizagem e avaliação:

- Uso de **avaliações orais como complemento**, quando necessário;
- Textos reduzidos e adaptados;
- Repetição e reforço de instruções;
- Uso de pistas visuais e organizadores gráficos;
- Ensino multisensorial.

Engajamento e comportamento:

- Reforço positivo frequente;
- Estímulo à participação ativa;
- Evitar exposição negativa;
- Incentivar autonomia com suporte gradual.

Importante:

O aluno **não necessita de professora de apoio individual**, mas sim de **adaptações pedagógicas bem estruturadas e orientação adequada ao professor**.



4. TREINAMENTO PARENTAL

A família desempenha papel central no manejo do quadro, sendo recomendado:

- Estabelecimento de **rotina estruturada e previsível**;
- Organização do ambiente domiciliar com redução de estímulos;
- Uso de **comandos claros, objetivos e consistentes**;
- Reforço positivo imediato para comportamentos adequados;
- Evitar reforço inadvertido de comportamentos inadequados;
- Supervisão ativa nas tarefas escolares;
- Divisão de atividades em pequenas etapas;
- Estímulo à autonomia progressiva;
- Alinhamento contínuo com escola e equipe terapêutica.

5. MANEJO FARMACOLÓGICO

- **Manter uso contínuo de LYBERDIA**;
- **Iniciar ARISTAB**, conforme prescrição médica, com monitoramento de resposta clínica e possíveis efeitos adversos;
- Retorno programado para reavaliação clínica e ajuste terapêutico.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Trata-se de um quadro com impacto funcional relevante, que exige abordagem **multidisciplinar, contínua e integrada**, com alinhamento entre equipe de saúde, família e escola. As intervenções propostas têm como objetivo promover **melhora da funcionalidade global, autonomia, desempenho acadêmico e qualidade de vida**.

Coloco-me à disposição para esclarecimentos adicionais e acompanhamento evolutivo do caso.

Dr. LIVIO F. S. CHAVES

CRM-GO: 10.050 | RQE: 5430

Residência Médica em Pediatria – HC/UFG-GO

Qualificação acadêmica em Neuropsiquiatria da Infância e Adolescência – HC/UFG-GO e em Psiquiatria Infantil – Santa Casa-RJ

Mestre em Farmacologia/TDAH – Instituto de Ciências Biológicas – UFG-GO

Membro e Secretário do Departamento Científico de Desenvolvimento e Comportamento da Sociedade Brasileira de Pediatria

Data: 18/05/2026

Dr. Livio Francisco S. Chaves
Pediatria RQE 5430
Desenvolvimento e Comportamento Infantil
CRM-GO 10.050
Av. Ricardo Paranhos 361
Sejafor Marista - Goiânia GO